

PROPOSTA CONFIDENCIAL · GRUPO GRADUAL

BCM

Parceria estratégica para transformar o Grupo Gradual no primeiro parceiro clínico e científico da plataforma ABA digital mais completa do Brasil.

R\$ 75.000 em 3 tranches · 5% da LaVita Code · risco protegido por gatilhos reais

Dra. Leila Bagaiolo · Dra. Claudia Romano Pacifico · Grupo Gradual

TESE CENTRAL

Vocês não entram para comprar promessa. Entram para capturar a primeira janela de validação clínica, produto pronto e participação estratégica.

35min

PEI gerado com baselines, metas e PDF defensável

32

jogos terapêuticos com telemetria clínica

3+

protocolos BCM default, sem limitar o método clínico

OERA+

protocolos específicos do Gradual podem virar nativos

RESUMO EXECUTIVO

Uma decisão simples: entrar agora como parceiro fundador ou assistir o padrão ser definido por outro.

O BCM já existe. A parceria reduz risco, acelera validação científica e cria um ativo comercial defensável para os dois lados.

O produto

Plataforma clínica ABA digital completa: avaliação, PEI, CAA, rotinas, jogos, telemetria, relatórios e Visão 360.

O deal

5% da LaVita Code por **R\$75 mil**, pagos em 3 tranches atreladas a assinatura, usuários pagantes e publicação ou escala.

O diferencial

Kernel genérico capaz de aceitar um ou mais protocolos. PSRF, PSFA e EPS-PCA são defaults BCM; OERA e a lista preferencial do Gradual podem entrar como protocolos nativos.

O risco protegido

A tranche 2 só é ativada com **50 usuários pagantes ativos**. O segundo cheque vem depois da prova, não antes.

O retorno direto

6 meses gratuitos, 30% de desconto permanente no plano clínica, dados reais, coautoria e integração OERA.

A urgência

Validade de 15 dias. A primeira parceria clínica define posição, autoria, dados e narrativa de mercado.

INVEST

POR QUE AGORA

A pressão regulatória já chegou. O mercado ainda não tem um padrão.

Quando a lei cria obrigatoriedade antes da existência de ferramentas, quem chega com método vira referência.

918K

crianças com TEA no Brasil - base INEP citada na proposta

+44%

crescimento de diagnósticos em 1 ano

94,2%

professores sem formação ABA

R\$320K

custo médio de litígio por não conformidade

O gatilho de mercado

- PEI obrigatório nas escolas.
- Planos de saúde exigem documentação clínica defensável.
- Clínicas precisam provar evolução, não apenas registrar sessão.

O risco de esperar

- Outro parceiro clínico ocupa o lugar de referência.
- Outro protocolo vira o primeiro nativo do marketplace.
- A janela de fundação vira janela de cliente comum.

Não é prontuário. Não é app de jogos. É um sistema clínico onde cada módulo alimenta o próximo.

Avaliação clínica

3 protocolos default BCM + protocolos específicos do Gradual, isolados ou combinados.



Kernel de decisão

Processa dados, deriva metas e organiza plano clínico.



PEI automático

Baselines, metas SMART, critérios de mastery e PDF.



Intervenção ativa

Jogos, rotinas, CAA, FCT e VB-MAPP.



Evidência contínua

Telemetria, relatórios, ANS, escola e família.

1

ambiente único

avaliação, intervenção e monitoramento

0

retrabalho clínico

o dado nasce estruturado e segue o fluxo

360°

visão integrada

criança, terapeuta, família e escola

Frase de posicionamento: BCM transforma avaliação clínica em plano de intervenção mensurável - e transforma intervenção em evidência.

O BCM já nasce com um ecossistema completo.

A proposta não é financiar uma ideia. É acelerar um ativo funcional com módulos já definidos.

01 · PSRF-BCM

Triagem de repertório funcional: 21 probes, 7 domínios, output direto para metas.

02 · PSFA-BCM

Análise funcional: 4 condições + controle, hipótese funcional e confiança.

03 · EPS-PCA

Perfil sensorial: 24 trials, 5 canais, adaptação de UX e rotina.

04 · Kernel

Motor clínico genérico para derivar metas, intervenções e governança.

05 · PEI Digital

Gerado em 35 min com baselines, SMART, mastery e PDF defensável.

06 · Minha Voz

CAA com PECS, voz PT-BR, modo livre, modo clínico e FCT.

07 · Rotinas

Economia de fichas, fading, reforços e execução vinculada ao PEI.

08 · 32 Jogos

5 mundos com telemetria: acertos, erros, latência e nível de ajuda.

09 · Visão 360

Dashboard com PSRF, PSFA, EPS-PCA, PEI e comportamento.

10 · Relatórios

PDF clínico, ANS, escolar, progresso e exportação por período.

11 · Acesso progressivo

Níveis por vínculo clínico: criança, responsável, terapeuta e admin.

12 · Stack SaaS

Angular, Ionic, NestJS, Prisma, PostgreSQL, AWS, Claude e LGPD.

O verdadeiro ativo não é só o PEI. É o kernel que aceita um ou mais protocolos estruturados.

Os 3 protocolos BCM são default. O Gradual pode operar com os próprios protocolos, sem abandonar o método que já usa.

Inputs clínicos configuráveis

- **Defaults BCM:** PSRF-BCM, PSFA-BCM, EPS-PCA
- **Gradual:** OERA como prioridade
- **Lista preferencial:** VB-MAPP, ABLLS-R, PEP-3, CARS-2, Vineland-3, SRS-2
- **Regra:** usar 1 protocolo ou combinar vários no mesmo caso clínico

Kernel BCM

- Mapeia domínios e escalas
- Processa dados de avaliação
- Deriva metas clínicas
- Aciona jogos, rotinas, CAA e FCT
- Gera evidência contínua

Outputs

- PEI automático
- Metas SMART
- Baselines auditáveis
- Critérios de mastery
- Relatórios para escola, ANS e família

Mensagem comercial: o BCM não força o Gradual a trocar de método. O terapeuta pode escolher OERA, os defaults BCM ou uma combinação de protocolos. O kernel normaliza os dados e transforma o método de vocês em PEI, metas, jogos, rotinas e relatórios.

O BCM deve rodar o protocolo de vocês - não substituir a clínica de vocês.

PSRF, PSFA e EPS-PCA continuam como protocolos default do BCM. A proposta permite que o Gradual use um ou mais protocolos próprios/preferenciais - OERA, VB-MAPP, ABLLS-R, PEP-3, CARS-2, SRS-2, Vineland-3 e outros definidos pela equipe clínica.

Catálogo nativo Gradual

Lista inicial para validação com Dra. Leila e Dra. Cláudia. O ponto central é a arquitetura: cada protocolo entra com domínio, escala, regra de interpretação e output clínico.

PRIORITÁRIO

OERA

protocolo fundador do Gradual dentro do BCM

LINGUAGEM

VB-MAPP

habilidades verbais e plano de intervenção

REPERTÓRIO

ABLLS-R

habilidades básicas de linguagem e aprendizagem

DESENVOLVIMENTO

PEP-3

perfil psicoeducacional e desenvolvimento

RASTREIO

CARS-2 / SRS-2

escalas de severidade e responsividade social

ADAPTAÇÃO

Vineland-3

comportamento adaptativo e vida diária

Como o terapeuta usa

- Escolhe o protocolo do caso: **default BCM**, **Gradual** ou **combinação**.
- Aplica dentro do fluxo digital, sem planilhas paralelas.
- Kernel transforma respostas em domínios, baselines, metas e critérios de mastery.
- PEI, jogos, CAA, FCT, rotinas e relatórios saem conectados ao protocolo escolhido.

1

Protocolo escolhido



2

Mapeamento clínico



3

Kernel BCM



4

PEI + intervenção

Frase-chave para o investidor: o Gradual não entra para adaptar sua clínica ao BCM. O BCM entra para transformar os protocolos do Gradual em software, escala, dados e propriedade estratégica.

OERA COMO PRIMEIRO PROTOCOLO PARCEIRO

O Grupo Gradual pode ocupar a posição mais valiosa: dono do primeiro catálogo parceiro de protocolos.

Na prática, o que acontece:

1 · MAPEAMENTO

OERA e a lista preferencial do Gradual são traduzidos para o modelo genérico do kernel.

2 · CADASTRO

Protocolos Gradual entram como opções de avaliação, começando pelo OERA.

3 · APLICAÇÃO

Terapeuta aplica digitalmente, no fluxo clínico do BCM.

4 · PEI

Kernel gera metas a partir do protocolo ou da combinação escolhida.

5 · DADOS

Uso real vira evidência, publicação e vantagem institucional.

Por que isso vale mais do que os 5%

- **Crédito científico:** Gradual vira primeiro parceiro de catálogo protocolar.
- **Vantagem comercial:** clínicas entram com o padrão já validado.
- **Dados acadêmicos:** base real para publicação conjunta.
- **Barreira competitiva:** primeiro protocolo fundador define reputação e taxonomia.
- **Modelo futuro:** outros parceiros pagarão para cadastrar protocolos no marketplace.

MERCADO E RECEITA RECORRENTE

O BCM captura uma dor que é clínica, escolar, jurídica e financeira ao mesmo tempo.

Quem paga

- Terapeutas independentes - plano profissional.
- Clínicas ABA - plano clínica.
- Escolas e redes de ensino - plano escola.
- Prefeituras e secretarias - contratos enterprise/white-label.

Quem não paga

A família nunca paga.

O acesso é liberado via código gerado pelo profissional. Isso cria adoção social sem transferir custo para a família.

R\$297

Profissional/mês · até 10 crianças

R\$997

Clínica/mês · até 30 crianças

R\$1.997

Escola/mês · pool de 50 crianças

B2G

Enterprise municipal por número de crianças

PROJEÇÕES CONSERVADORAS

Do piloto ao breakeven: a rota depende de uso real, receita recorrente e prova clínica.

PERÍODO	TRAÇÃO ESPERADA	RECEITA MENSAL ESTIMADA	LEITURA COMERCIAL
Mês 1-3 Piloto Gradual	0 pagantes - uso gratuito de validação	R\$ 0	Provar uso, onboarding, dados e melhoria de produto.
Mês 4-6 Pós-milestone	15 pagantes	R\$ 10.000	Primeira prova de disposição a pagar.
Mês 7-9 Expansão Fortaleza	50 pagantes	R\$ 35.000	Ativa tranche 2 e valida canal inicial.
Mês 10-12 Expansão regional	120 pagantes	R\$ 85.000	Modelo de aquisição e retenção mais claro.
Ano 2 - Q1	250 pagantes	R\$ 175.000	Escala SaaS com mix profissional, clínica e escola.
Ano 2 Breakeven	350+ pagantes	R\$ 245.000	Empresa em rota de sustentabilidade.

Mix estimado

60% profissional · 30% clínica · 10% escola/enterprise.

Municipal

1 contrato de 500 crianças pode gerar R\$15k-R\$25k/mês.

Alavanca

1 contrato municipal equivale a dezenas de assinantes profissionais.

POR QUE O GRUPO GRADUAL

Vocês têm o que não se compra. O BCM tem o que leva anos para construir.

O que o Gradual traz

- 23 anos de operação clínica ABA.
- Dra. Leila Bagaiolo: autoridade científica e rede acadêmica.
- 2.000+ crianças atendidas.
- ~100 ATs formados por ano.
- Parcerias institucionais citadas: HC/USP e PUC-SP.
- Jogos digitais com lógica ABA que podem virar ativo vivo.

O que o BCM entrega

- Plataforma funcional em produção.
- Kernel clínico que transforma avaliação em PEI.
- Telemetria real de intervenção.
- Produto SaaS pronto para escalar.
- Base técnica para OERA nativo e publicação conjunta.
- Modelo de receita recorrente com família fora do custo.

Frase de fechamento do slide: juntos, Gradual e BCM chegam onde nenhum dos dois chega sozinho.

Um time enxuto, com motivação real e produto já construído.



Rafael Dias

Fundador · CTO · Engenheiro de Software

Autista, engenheiro sênior com 10+ anos em Angular, NestJS e plataformas SaaS. Investiu R\$150 mil do próprio bolso para construir o BCM.



Laura Bastos

Co-fundadora · Head de Produto

Psicologia, Acompanhante Terapêutica, pesquisadora em TEA e tecnologias assistivas. A origem clínica e humana do projeto.

R\$150K

capital próprio investido

3 anos

de construção contínua

AWS

Activate aprovado

Claude

IA aplicada ao kernel e histórias

Autoridade emocional + autoridade técnica: produto nasceu da vivência, mas só se sustenta porque foi construído com arquitetura SaaS, protocolos clínicos e governança.

A PROPOSTA

5% da LaVita Code por R\$ 75.000 - com aporte em etapas e gatilhos objetivos.

Tranche 1 - Assinatura

R\$30K

Contrato assinado, acesso gratuito, viagem inicial, onboarding e início da integração OERA.

Tranche 2 - Prova de mercado

R\$25K

Somente com 50 usuários pagantes ativos na base total da plataforma.

Tranche 3 - Resultado

R\$20K

Publicação científica conjunta ou 100 usuários pagantes ativos.

O que vocês recebem

- 5% da empresa.
- 6 meses gratuitos para toda a clínica.
- 30% de desconto permanente no plano clínica.
- OERA + protocolos preferenciais do Gradual como catálogo nativo BCM.
- Direito a voto em decisões técnicas de produto com impacto clínico.
- Coautoria e dados reais de uso.

O que protege o investidor

- Tranche 2 não é por data - é por receita ativa.
- Tranche 3 exige publicação ou escala.
- Uso gratuito exige mínimo de 10 crianças em 60 dias.
- Acesso a relatórios trimestrais de uso, receita e roadmap.

PAGA PELA PROVA - NÃO PELA PROMESSA

A estrutura foi desenhada para reduzir risco e aumentar confiança a cada etapa.

Assinatura

R\$30K
contrato, acesso, viagem e onboarding



Uso real

terapeutas usam, crianças usam, dados
são gerados



50 pagantes

R\$25K
somente com prova de mercado



Publicação/100 usuários

R\$20K
resultado científico ou escala

Por que isso é justo para o Gradual

- O segundo cheque só vem quando o produto já provou tração paga.
- O acesso gratuito permite validar sem custo operacional inicial.
- O Gradual influencia o produto antes que ele fique engessado.

Por que isso é justo para a LaVita Code

- A tranche 1 financia execução, presença em SP e integração inicial.
- O uso real gera dados e valida o produto.
- O parceiro entra com participação ativa, não apenas com capital.

Regra de confiança: se não houver prova de mercado, a tranche 2 não dispara.

RETORNO ESPERADO

O retorno combina equity, economia direta, acesso tecnológico e valor científico.

Valor direto recebido

6 meses Plano Clínica gratuito	R\$ 5.982
30% desconto permanente por 10 anos	R\$ 35.892
OERA + catálogo Gradual como protocolo nativo	estratégico
Dados clínicos reais e coautoria	acadêmico
Subtotal monetizável direto	R\$ 42.000+

Valor potencial dos 5%

Entrada hoje	R\$ 75.000
Com 350 assinantes - breakeven	R\$ 125K-R\$175K
Com 1.000 assinantes	R\$ 375K-R\$500K
1 contrato municipal + 500 assinantes	R\$ 600K-R\$900K
Presença nacional - 5 estados	R\$ 1M-R\$2M

Observação: projeções e valuation são estimativas comerciais por múltiplo de MRR e não constituem garantia de retorno.

Âncora de decisão: por R\$75 mil, o Gradual compra posição estratégica antes da rodada, antes da escala e antes de outros protocolos entrarem.

RETORNO ANTES DA ESCALA

A parceria pode gerar economia operacional mesmo antes do BCM crescer.

LaVita Code como parceira tecnológica do Grupo Gradual - 25% abaixo do valor de mercado enquanto a sociedade estiver ativa.

Serviços incluídos

- Desenvolvimento de sistemas internos.
- Manutenção e evolução de sistemas existentes.
- Integrações, APIs, portais e aplicativos.
- Suporte técnico especializado em clínica ABA.

Exemplo de payback

Se hoje a softhouse custa R\$ 8.000/mês:

- 25% de desconto = R\$ 2.000/mês economizados.
- Economia anual = R\$ 24.000.
- Payback do investimento total = 3,1 anos só com economia direta.

Se o custo atual for R\$12.000/mês, a economia anual sobe para R\$36.000 e o payback cai para 2,1 anos.

Mensagem de segurança: mesmo que o BCM demore mais para escalar, a parceria já cria retorno operacional independente do equity.

Participação minoritária com voz real no produto - sem bloquear a operação.

Estrutura societária proposta

Rafael Dias - LaVita Code	95% fundador, CTO, produto e tecnologia
Grupo Gradual / Leila Bagaiolo	5% parceiro estratégico, validação clínica, rede e voto técnico-clínico

Direitos do sócio minoritário

- Relatório trimestral de uso, receita e roadmap.
- **Direito a voto em decisões técnicas de produto** que impactem protocolo clínico, UX terapêutica, dados clínicos, relatórios, jogos terapêuticos, OERA e integrações de avaliação.
- Coautoria em publicações científicas com dados BCM.
- Preferência de compra em rodada futura - pro-rata.
- Desconto permanente no Plano Clínica.
- Participação na priorização da lista de protocolos Gradual que entram no kernel.

O que não está incluído

- Acesso ao código-fonte.
- Direito de veto em parcerias comerciais externas.
- Obrigação de aporte adicional.
- Interferência em execução técnica diária sem rito de governança.

Papel da Dra. Leila

- Validação dos protocolos embarcados.
- Integração OERA + lista preferencial Gradual em até 6 meses.
- Coautoria científica.
- Participação em encontros presenciais.
- Abertura de rede acadêmica e institucional.

PLANO DE EXECUÇÃO

Do acordo ao primeiro usuário em até 30 dias.

SEMANA 1

Contrato assinado, tranche 1 liberada, viagem Rafael + Laura para SP, alinhamento presencial e início do onboarding.

SEMANA 2

Entrega dos jogos Gradual, mapeamento inicial do OERA, acessos da clínica e primeiros terapeutas preparados.

MÊS 1

Mínimo de 10 crianças cadastradas, primeiros dados reais, feedback clínico direto e iteração rápida.

MÊS 3

Relatório de uso, expansão comercial inicial e gatilho da tranche 2 apenas se houver 50 usuários pagantes ativos.

MÊS 6

OERA nativo, publicação conjunta ou 100 usuários pagantes, tranche 3 e expansão nacional iniciando.

Primeira meta concreta: o BCM rodando no Gradual em até 30 dias.

OBJEÇÕES RESPONDIDAS

As principais dúvidas já foram tratadas na estrutura do acordo.

“E se o produto não vender?”

A tranche 2 só é paga com 50 usuários pagantes ativos. Sem venda, não há segundo aporte.

“E se a clínica não usar?”

O acesso gratuito exige mínimo de 10 crianças nos primeiros 60 dias. Sem uso, não há validação real para ninguém.

“E se virar só mais um software?”

O diferencial é o kernel clínico + OERA nativo + telemetria + relatórios defensáveis. Não é apenas cadastro ou prontuário.

“E se a participação for pequena?”

5% agora é posição de fundador de parceria, antes de receita, rodada e escala. O valor está no timing.

“E se houver conflito técnico?”

O Gradual tem direito a voto nas decisões técnicas de produto com impacto clínico. Rafael mantém a responsabilidade de viabilidade, arquitetura e execução técnica.

“E se o retorno demorar?”

A economia de softhouse e desconto permanente criam retorno direto independente da escala do BCM.

QUADRO DE DECISÃO

A decisão não é “investir em uma startup”. É escolher posição na fundação de um novo padrão clínico digital.

Se o Gradual entra agora

- Vira primeiro parceiro clínico do BCM.
- Molda o produto antes da escala.
- Integra OERA e catálogo Gradual como protocolo fundador.
- Ganha coautoria, dados e participação.
- Ocupa a narrativa científica do mercado.

Se o Gradual espera

- Outro parceiro pode ocupar a posição.
- Outro parceiro pode virar o primeiro catálogo nativo.
- A entrada futura tende a ser como cliente, não como fundador.
- A janela de validação inicial pode fechar.
- O poder de moldar produto diminui.

Resumo persuasivo: o custo da espera não é apenas perder o deal. É perder a posição.

TERMOS RESUMIDOS

Uma proposta clara, mensurável e pronta para contrato.

Produto	Plataforma clínica ABA digital completa - funcional hoje.
Investimento total	R\$ 75.000 em 3 tranches.
Equity oferecido	5% da LaVita Code.
Tranche 1	R\$30.000 na assinatura + onboarding + viagem inicial + início OERA.
Tranche 2	R\$25.000 apenas com 50 usuários pagantes ativos.
Tranche 3	R\$20.000 com publicação conjunta ou 100 usuários pagantes.
Acesso Gradual	6 meses gratuitos, todos os terapeutas e crianças, condicionado a uso mínimo.
Desconto permanente	30% no Plano Clínica enquanto a sociedade estiver ativa.
Protocolos Gradual	OERA prioritário + lista preferencial configurável como catálogo nativo fundador do BCM.
Serviços LaVita Code	25% abaixo do mercado para desenvolvimento de software.
Validade	15 dias - até 22 de maio de 2026.

PRÓXIMOS PASSOS

Vamos transformar o primeiro piloto em referência nacional.

Assinar intenção, formalizar contrato, liberar tranche 1, iniciar SP e colocar os primeiros terapeutas na plataforma em 7 dias.

Vocês têm 23 anos construindo o que o BCM precisa. Eu tenho o que leva anos construir: a plataforma pronta. Juntos chegamos onde nenhum dos dois chega sozinho.

Contato

Rafael Dias

Fundador · LaVita Code

Email: rafaeldias@lavitacode.com.br

Telefone: +55 85 9 9444-8858

Site: lavitacode.com.br

Documento confidencial

Elaborado exclusivamente para o Grupo Gradual.

Esta proposta é comercial e estratégica. Termos finais devem ser formalizados em contrato com assessoria jurídica.